

Ergonomie et matériel spécifique en odontologie pédiatrique

Cours OP 4ème année - Pr Farsi

Plan du Cours

1. Introduction
2. I. Définition de l'ergonomie
3. II. La position de travail (Le choix du fauteuil, La position de travail)
4. III. L'aménagement ergonomique (Réception, Salle d'attente, Salle de soins)
5. IV. Matériel spécifique en odontologie
6. Conclusion

Définition de l'ergonomie

Étymologie : Grec 'ergon' (travail) + 'nomos' (loi).

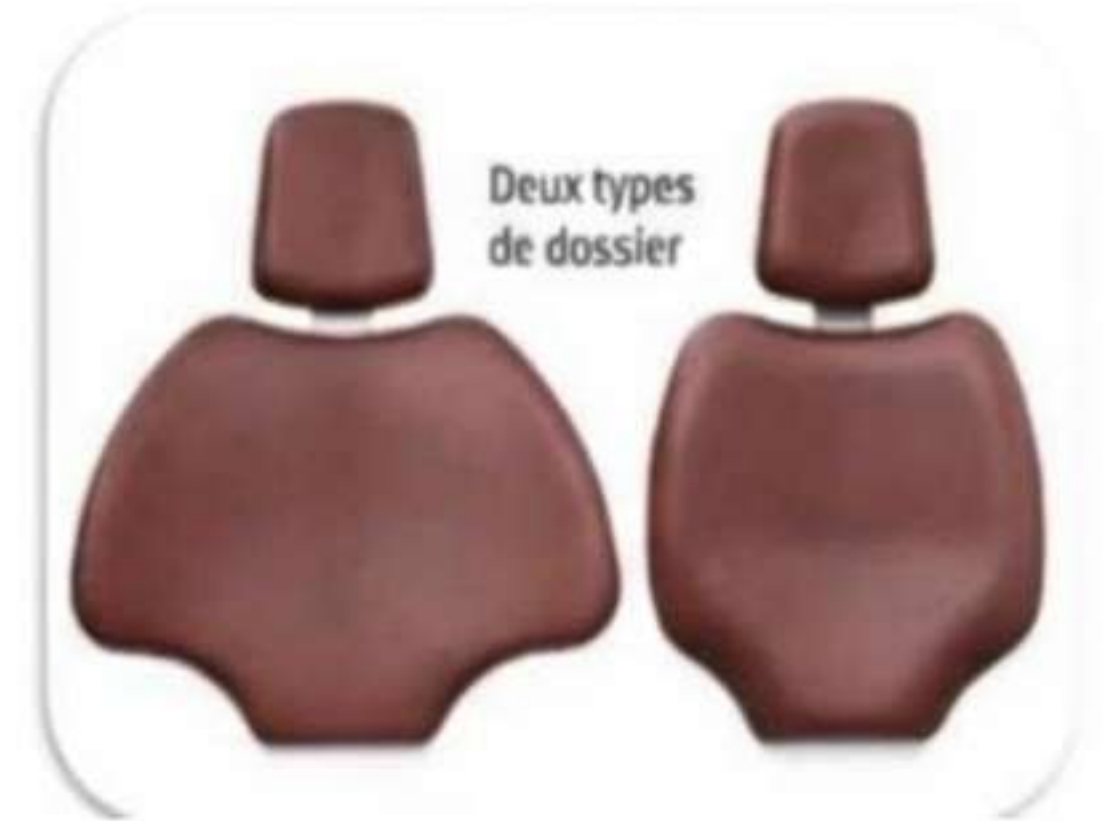
Définition : Science multidisciplinaire définie comme **l'ensemble des études et recherches visant à organiser rationnellement le travail et à concevoir les équipements en adéquation avec les capacités et les limites de l'être humain.**

Objectif : **Optimiser l'organisation du travail dans un espace et un temps contraints afin de garantir la qualité des soins.**

II. La Position de Travail : Le Choix du Fauteuil

Les 7 Critères de Choix

1. Offrir un accès facile au patient et lui assurer une position confortable.
- 2. Avoir un dossier étroit et plat.**
3. Avoir une tête orientable et assurant un calage de la tête.
4. Mécanisme de commande électrique digital ou à pied.
5. Permettre une position suffisamment basse pour avoir la bouche du patient à une hauteur correcte.
6. Impératifs liés au bruit.
- 7. Fauteuil descend très bas et permet facilement à un enfant handicapé de s'y transférer.**



II. La Position de Travail : Posture du Praticien

Définition

Vise à structurer la posture lors des actes cliniques en définissant des segments corporels précis.

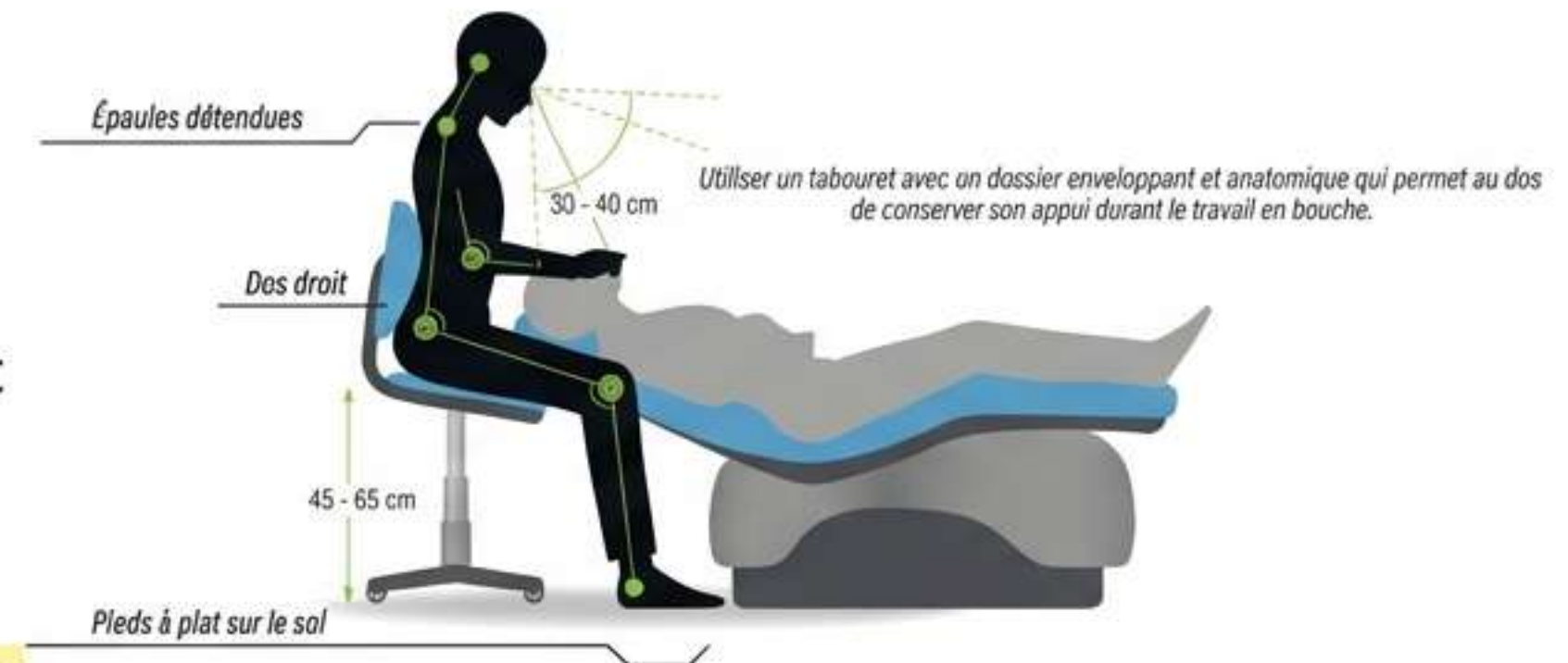
Segments Corporels

- **Bras** : Maintenus globalement verticaux.
- **Avant-bras** : Restent horizontaux.
- **Hauteur** : Le patient est positionné approximativement au niveau des coudes du praticien.

Position de Base Idéale

Le travail « à midi », reconnu pour son efficacité en termes d'économie rachidienne. [Ref : Q1]

- **Tête du patient** : Repose sur les cuisses du praticien.
- **Jambes du patient** : Installées sur les genoux de l'accompagnant qui lui fait face.



III. L'Aménagement : Réception & Salle d'Attente

Respecter les normes de sécurité et l'accessibilité aux personnes en situation de handicap.

1. La Réception



- Emplacement central (contrôle des déplacements).
- Décoration rassurante et accueillante.
- Bureau avec ordinateur (gestion planning).

2. La Salle d'Attente



- Atmosphère non ennuyeuse (Téléviseur, journaux).
- Bien visible depuis le secrétariat.
- Isolation phonique (bruits de turbines = anxiété).
- Tendance : « L'art de végétaliser un espace » (plantes).

III. L'Aménagement : La Salle de Soins (Structure)

Surface Totale Idéale
20 m²

Salle de chirurgie
environ 10 m²
(fauteuil, rangements,
scialytique)



Sas d'entrée
+ ou - 2,5 m²
(sépare deux
environnements
d'asepsie)

Salle de stérilisation
environ 8 m²
(si intégrée/attendant)

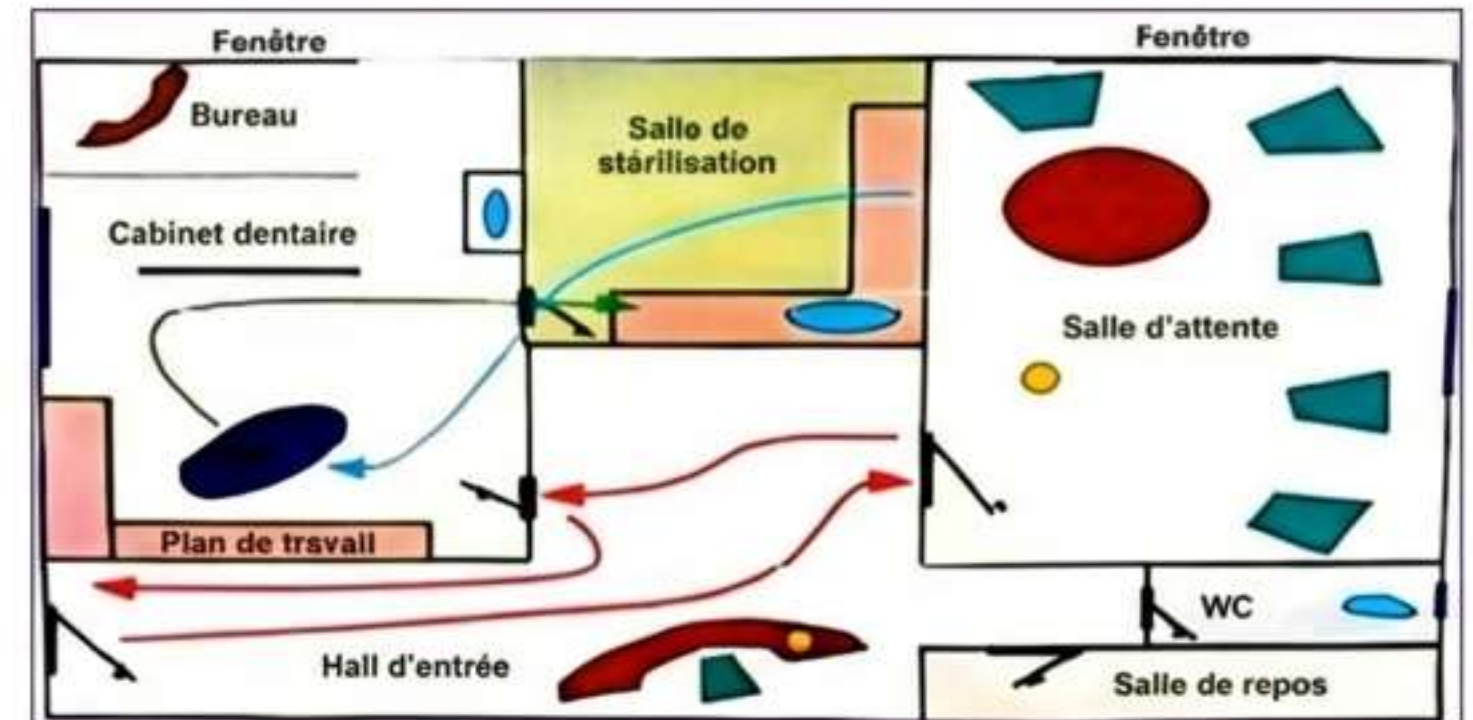
Matériaux : Éclairage lumière naturelle. Sol en **PVC compact** (résistant aux roulettes).

III. L'Aménagement : Stérilisation & Circulation

La Salle de Stérilisation

- Située centralement (trajet court) et vaste.
- Équipement requis : Meuble de rangement, paillasse, évier large, équipement de stérilisation.

Concept de Circulation « à sens unique »



- Le patient doit suivre un circuit simple : Entrée → Accueil → Salle d'attente → Soins → Sortie.
- Instruments : Circuit distinct pour les dispositifs souillés vs stériles.

IV. Matériel Spécifique : Environnement & Radiologie

Environnement Psychologique

Knowledge Card

- Objectif : Créer un environnement rassurant et ludique.
- Moyens : Gobelets, masques et instruments colorés.
- Tenue : Blouses vives.
- Protection : Lunettes (contre le scialytique).



Matériel Radiographique

Denture temporaire /
Début mixte

Films ISO taille 0 (2 × 3 cm)
[Ref: Q4]

À partir de 8 ans

Films ISO taille 2 (3 × 4 cm)
[Ref: Q4]

IV. Matériel Spécifique : Systèmes d'Anesthésie

Objectif : Une anesthésie moins invasive.

Systèmes Électroniques

- Exemple : SleeperOne®



Aiguilles

- Aiguilles fines (ex : Intralig-S ®).



IV. Matériel Spécifique : Anesthésie (MEOPA)

Anesthésie au MEOPA

Définition : Mélange Équimolaire d'Oxygène (50%) et de Protoxyde d'Azote (50%).

Nom commun : « Gaz hilarant ».

État du patient : Reste éveillé et conscient.

Knowledge Card

Indications & Effets :

- Procure une sédation consciente. [Ref: Q2]
- **Indication :** Diminuer l'anxiété de l'enfant. [Ref: Q2]



IV. Matériel Spécifique : Aspiration & Isolement

Digues (Latex ou sans Latex)

- Exemple : FlexiDam.



Écarteurs Buccaux

- Écarteurs spécifiques pour l'accès visuel.



Autres Outils

- Pompes à salive adaptées.
- Optragate.
- Bite blocks / Cale-bouche (Exemple coloré).



1PC Random Color

By dentiste web

IV. Matériel Spécifique : Prévention (Vernis & Pâtes)

Vernis Fluorescent

- **Usage** : Prévention des caries.
- **Exemples** : Cervitec Gel® (chlorhexidine + fluor) ou Duraphat®.



Pâtes Prophylactiques

- **Composition** : Teneur en phosphate de calcium amorphe (ACP).
- **Usage** : Reminéralisation.
- **Exemple** : Enamel Pro®.



IV. Matériel Spécifique : Restauration

Composites et Compomères

- **Compomères** : Mélange de CVI et composite.
- **Propriétés** : Esthétique + Résistance mécanique.
- **Indication** : Pour les cavités plus importantes sur dents temporaires.



Ciments Verres Ionomères (CVI)

- **Propriétés** : Libération de fluor et application facile.
- **Exemple** : Fuji IX GP Extra®.



IV. Matériel Spécifique : Coiffes Pédodontiques (CPP)

Définition :

La coiffe pédodontique préformée est « incontournable » en odontologie pédiatrique.

Indications :

- Solution thérapeutique parfaite lors de lésions carieuses importantes. [Ref: Q3]
- Sur molaires temporaires. [Ref: Q3]



Conclusion

Les clés de la réussite :

« L'ordre, la rationalisation du travail et la méthode. »

Le Devoir du Praticien :

Accorder une attention particulière à l'organisation et l'agencement du cabinet.

La Priorité :

« Le choix d'instruments et de matériels adaptés, capables d'améliorer l'efficacité des soins et de faciliter la pratique quotidienne. »